

Patient: Schmidt, Johannes

Geburtsdatum: 12.08.1970

Wohnort: Fürth

Patienten-ID: AI-55421-Y

Untersuchungsdatum: 10.05.2026

Überweiser: Dr. med. K. Ortho

BEFUNDBERICHT: MRT DER LENDENWIRBELSÄULE (NATIV)

Klinische Angaben

Bekannte chronische Lumboischialgie rechtsbetont. Zunehmende Schmerzausstrahlung in das rechte Bein (Dermatom L5). Ausschluss eines akuten Bandscheibenvorfalls oder einer rezessalen Stenose.

Untersuchungstechnik

Sagittale T1w, sagittale und axiale T2w TSE, sagittale STIR-Sequenz. Keine intravenöse Kontrastmittelgabe.

Befund

Reguläre Lordose der Lendenwirbelsäule. Keine Gefügestörung, kein Nachweis einer Spondylolisthesis. Die Wirbelkörperhöhen sind intakt. Unauffälliges Knochenmarks-Signal ohne Hinweis auf ein akutes Knochenmarködem oder suspekte osteodestruktive Foliae.

Segment L3/L4: Initiale Chondrose. Leichte breitbasige Bandscheibenprotrusion ohne wesentliche Einengung des Spinalkanals oder der Neuroforamina.

Segment L4/L5: Deutliche Höhenminderung des Intervertebralraums (Osteochondrose Modic II). **Nachweis eines mediolateralen bis nach rechts intraforaminal reichenden Bandscheibenprolapses.** Hierdurch kommt es zu einer deutlichen Einengung des rechten Neuroforamens mit Tangierung und möglicher Kompression der austretenden Nervenwurzel L4 rechts sowie der ascendierenden L5 Wurzel im Recessus.

Segment L5/S1: Mäßige Spondylarthrose beidseits. Das Bandscheibenfach ist unauffällig, die Neuroforamina sind frei. Keine signifikante Spinalkanalstenose.

Beurteilung

1. Mediolateraler, nach rechts intraforaminaler Bandscheibenprolaps L4/L5 mit konsekutiver relativer Spinalkanalstenose und deutlicher Einengung des rechten Neuroforamens. Korreliert gut mit der klinisch beschriebenen Radikulopathie L5 rechts.
2. Geringe degenerative Veränderungen L3/L4 ohne neuroforaminale Enge.
3. Kein Anhalt für Spondylodiszitis oder maligne ossäre Läsionen.

Dr. med. H. Weber
Facharzt für Radiologie